

Zdrowienie jest procesem — a SEED-AN wymaga innego podejścia

Nawroty AN są częste (~30–50% w 2 lata). Plan profilaktyki nawrotu = sygnały wczesne + sieć + zachowania. SEED-AN: jakość życia > pełna remisja.

CZAS: ostatnia faza terapii (sesje 25–30 CBT-E lub MANTRA) + monitorowanie długoterminowy

REALIZACJA: każdy pacjent kończący terapię; SEED-AN — odrębny model

ŹRÓDŁO: Carter i in. (2012, predyktory nawrotu); Berends i in. (2018, meta); Robinson (2014, SEED-AN); Wonderlich i in. (2020, SEED palliative)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **częstość i mechanizmy nawrotów** w AN + **definicja i podejście do SEED-AN** (Severe and Enduring Eating Disorder). Sekcja 02 — **siedem komponentów planu** profilaktyki nawrotu. Sekcja 03 — **mój plan profilaktyki**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

AN ma wysoką częstość nawrotów: 30–50% w ciągu 2 lat po remisji (Carter i in., 2012; Berends i in., 2018 meta-analiza). Główne predyktory: nieosiągnięcie pełnej wagi przed zakończeniem, krótki czas pracy w fazie konsolidacji, niska samoocena, perfekcjonizm. **Plan profilaktyki nawrotu:** rozpoznawanie wczesnych sygnałów, sieć wsparcia, konkretne zachowania ochronne, plan awaryjny. SEED-AN (Severe and Enduring Eating Disorder — Anorexia Nervosa; Robinson, 2014) — pacjenci z >7-letnią historią AN, wielokrotnymi niepowodzeniami leczenia, niską jakością życia. **Cel u SEED-AN nie jest „pełna remisja”** — to często niemożliwe — lecz **jakość życia**, redukcja cierpienia, zapobieganie powikłaniom. Model palliative w psychiatrii (Wonderlich i in., 2020): legalny, etyczny, oparty na danych.

01 Nawroty w AN + SEED-AN — różne ścieżki, różne cele

KLASYCZNE AN — CEL: PEŁNA REMISJA

30–50% nawrotu w 2 lata (Berends 2018). Predyktory: nieosiągnięcie pełnej wagi, krótka konsolidacja, niska samoocena, perfekcjonizm, EE w rodzinie. Profilaktyka: *sygnały wczesne* + sieć + zachowania ochronne + plan awaryjny.

SEED-AN — CEL: JAKOŚĆ ŻYCIA

>7 lat AN, wiele niepowodzeń. Pełna remisja często niemożliwa. Cel: *jakość życia*, redukcja cierpienia, bezpieczeństwo medyczne. Robinson (2014), Wonderlich i in. (2020): „*harm reduction*” (redukcja szkód) w psychiatrii — legalne, etyczne, dane.

SYGNAŁ WCZESNY NAWROTU	BEHAWIORALNY	POZNAWCZY / EMOCJONALNY
Pomijanie posiłków, „ <i>nie głodny/-a</i> ”	Powrót ćwiczeń, ważenia	Myśli „ <i>czuję się gruby/-a</i> ”
Spadek masy >1.5 kg w 2 tyg.	Body checking wraca	Powrót pro-ana/thinspo
Wybiórcze fear foods wracają	Wycofanie społeczne	Lęk przed jedzeniem roślin

02 Siedem komponentów planu profilaktyki nawrotu

1. **Lista sygnałów wczesnych** — pacjent zna *swoje* sygnały: jakie myśli, jakie zachowania, jakie emocje pojawiają się jako pierwsze. Każdy pacjent ma *indywidualny* profil. Lista 5–10 sygnałów: spisana, dostępna, dla bliskich też.
2. **Reguły kontrolne** — ważenie raz w miesiącu u lekarza lub dietetyka (nie w domu). Posiłki — regularnie (3+2+1). Dziennik tylko przy lapse'u, nie stale. Aktywność fizyczna — w określonych granicach, kontrolowana.
3. **Sieć wsparcia** — 3–5 osób, do których pacjent *może* zadzwonić, gdy sygnały się pojawiają: terapeuta, dietetyk, bliska osoba, grupa wsparcia. Sieć dostępna, znana, regularnie kontaktowana.
4. **Plan awaryjny** — co konkretnie zrobić, kiedy 3+ sygnały występują naraz: (a) kontakt z terapeutą, (b) wizyta u lekarza, (c) intensyfikacja kontaktów, (d) rozważenie krótkiej hospitalizacji jako interwencji wyprzedzającej.
5. **Praca z czynnikami ryzyka** — stres, kryzysy życiowe, transitions (przeprowadzka, rozwód, ciąża) — częste wyzwalacze. Plan dla okresów wysokiego ryzyka: częstsze kontakty z zespołem, dodatkowa praca terapeutyczna.
6. **Sesje wzmacniające (ang. *booster sessions*)** — sesje wzmacniające co 3–6 miesięcy w pierwszym roku po terapii. Krótkie (45–60 min), monitorują postępy, identyfikują problemy *zanim* staną się nawrotem.
7. **SEED-AN — modyfikacja celów** — u pacjentów z >7-letnią historią AN i wielokrotnymi niepowodzeniami: zmiana celu z „pełna remisja” na „jakość życia + bezpieczeństwo”. Mniejsza presja, więcej autonomii, dialog o akceptowalnym poziomie zaburzenia. Etycznie uzasadnione (Wonderlich 2020), wymaga zespołu doświadczonego w SEED.

03 **Mój plan profilaktyki nawrotu**

PIĘĆ SYGNAŁÓW WCZESNYCH NAWROTU, KTÓRE SĄ TYPOWE DLA MNIE

— myśli, zachowania, emocje; spisuję, żeby zauważyć

SIEĆ WSPARCIA — 3–5 OSÓB, DO KTÓRYCH MOGĘ ZADZWONIĆ

— imiona, kontakt, dostępność; aktywnie utrzymuję te kontakty

REGUŁY CODZIENNE, KTÓRE UTRZYMUJĘ DŁUGOTERMINOWO

— ważenie 1×/mies., posiłki 3+2+1, ćwiczenia w granicach, sen, czas dla bliskich

PLAN AWARYJNY: CO ZROBIĘ, JEŚLI 3+ SYGNAŁY WYSTĄPIĄ NARAZ

— konkretne kroki: kontakt z X, wizyta u Y, intensyfikacja Z

Klucz: nawrót AN *nie* jest porażką pacjenta — jest częścią naturalnej historii zaburzenia. Plan profilaktyki nawrotu zwiększa szansę utrzymania remisji i zapewnia szybką reakcję, kiedy sygnały się pojawiają. **SEED-AN to nie „kapitulacja”** — to *realistyczne* podejście do pacjentów, dla których pełna remisja po wielu próbach nie jest osiągalna. Cel: *jakość życia*, bezpieczeństwo medyczne, autonomia, godność. Wymaga doświadczonego zespołu i etycznie zaawansowanej dyskusji. **Komunikat dla pacjenta:** „kończysz terapię — ale to nie koniec pracy. Plan profilaktyki to nie znak braku zaufania, lecz realizm. AN to choroba przewlekła — jak cukrzyca czy depresja. Plan daje Ci narzędzia, jeśli sygnały wrócą”.

△ **Etyka SEED-AN:** decyzja o przejściu z modelu „recovery-oriented” na „quality of life” wymaga: dokumentacji wieloletnich niepowodzeń leczenia, oceny zdolności decyzyjnej pacjenta, dialogu z rodziną, zgody zespołu interdyscyplinarnego, regularnej rewizji decyzji. To nie rezygnacja z opieki medycznej (bezpieczeństwo żywieniowe nadal monitorowane), lecz zmiana celu. Kontrowersyjne, omawiane w literaturze (Geppert 2015; Wonderlich 2020; Westmoreland & Mehler 2016).